



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 16 — Exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

Classificação de gravidade (proposta de Roma / GOLD 2026), oxigênio controlado (88–92%), broncodilatador, corticoide 5 dias, antibiótico por critério, VNI precoce na hipercapnia, alta e transferência — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-16	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A exacerbação de DPOC é a segunda causa de internação por doença respiratória em adultos no SUS e tem mortalidade intra-hospitalar de 4–10% (até 25% quando há hipercapnia com acidose). No PS, os quatro erros que matam são: **oxigênio em alto fluxo** (hipercapnia por supressão do drive e alteração V/Q), **VNI tardia** na acidose respiratória, **não reconhecer a causa** (pneumonia, TEP, IC, pneumotórax) e **alta sem plano**. Este protocolo segue o GOLD 2026 e as recomendações da SBPT, com os fármacos disponíveis no SUS.

Fontes de ancoragem: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD 2026

Report (nov/2025), capítulo 5 — Management of exacerbations [GOLD 2026]; Celli BR, et al. An updated definition and severity classification of COPD exacerbations: the Rome proposal. *Am J Respir Crit Care Med* 2021;204:1251 [ROMA 2021]; Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. *Recomendações para o manejo da DPOC* (J Bras Pneumol, edição vigente) [SBPT]; Ministério da Saúde. *PCDT da DPOC* (Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 19/2021) [PCDT-MS 2021]; Rochweg B, et al. ERS/ATS guideline: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. *Eur Respir J* 2017;50:1602426 [ERS/ATS 2017]; Oczkowski S, et al. ERS guideline on high-flow nasal cannula. *Eur Respir J* 2022;59:2101574; Wedzicha JA, et al. ERS/ATS guideline: management of COPD exacerbations. *Eur Respir J* 2017;49:1600791; Austin MA, et al. (BMJ 2010;341:c5462 — O₂ titulado); Leuppi JD, et al. (REDUCE, JAMA 2013 — corticoide 5 dias).

Convenção de confiança: doses trazem a fonte; esquemas antimicrobianos são de prática consagrada e devem ser validados pela CCIH [VERIFICAR]. Itens [VERIFICAR]: VNI/BiPAP, gasometria em ≤30 min, cateter nasal de alto fluxo, máscara de Venturi, espaçadores, PCR.

1. Queixa — como o paciente chega

Tabagista (ou ex-tabagista, exposição a fumaça de lenha/biomassa) com dispneia crônica que **piorou nos últimos dias** (até 14 dias), "mais tosse", "catarro mais grosso e amarelo/esverdeado", "mais chiado", "não consigo fazer o que fazia", "acordo cansado", "o oxigênio não está dando conta". Sonolência, cefaleia matinal, confusão ou tremor (flapping) sugerem **hipercapnia**. Perguntar: diagnóstico prévio e espirometria, uso de O₂ domiciliar, VNI domiciliar, internações/UTI/IOT prévias, exacerbações no último ano, medicação inalatória e adesão, corticoide oral recente, tabagismo atual, vacinas.

Causas e diferenciais que mudam a conduta — pesquisar sempre

Grupo	Exemplos / pistas
Infecção respiratória (70–80%)	Vírus (rinovírus, influenza, VSR, COVID — 50%); bactérias (<i>H. influenzae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>M. catarrhalis</i> ; <i>P. aeruginosa</i> em DPOC grave/exacerbador frequente/ATB recente); purulência do escarro é o marcador clínico
Pneumonia	Febre alta, consolidação ao RX, PCR muito elevada → Protocolo 10 (muda antibiótico e prognóstico)
Poluição, fumaça de queimada, frio	Sazonal — frequente na região no inverno/seca
Diferenciais que simulam exacerbação	TEP (até 15–20% das exacerbações sem causa aparente: dor pleurítica, hipoxemia desproporcional, taquicardia, TVP), IC descompensada (ortopneia, edema, BNP), pneumotórax (dor súbita, assimetria), SCA, arritmia (FA), derrame pleural, aspiração
Iatrogenia	Suspensão de broncodilatador, sedativo/opioide/benzodiazepínico, betabloqueador não seletivo, O ₂ em alto fluxo no transporte

2. Clínica — definição e classificação de gravidade

2.1 Definição [GOLD 2026; ROMA 2021]

Evento agudo caracterizado por piora da dispneia e/ou tosse e expectoração em até 14 dias, podendo acompanhar-se de taquipneia e/ou taquicardia, frequentemente associado a inflamação local/sistêmica por infecção, poluição ou outra agressão. **O diagnóstico exige excluir os mimetizadores** (2.3 e seção 1).

2.2 Gravidade à apresentação — proposta de Roma adotada pelo GOLD 2026

Gravidade	CrITÉRIOS (na chegada)	Conduta / local
Leve	Dispneia (EVA 0–10) <5; FR <24; FC <95; SpO ₂ em repouso ≥92% em ar ambiente (ou queda ≤3% do basal); PCR <10 mg/L (se disponível)	Aumentar broncodilatador de curta ação; ambulatorial
Moderada	≥3 de 5: dispneia ≥5; FR ≥24; FC ≥95; SpO ₂ <92% (ou queda >3%); PCR ≥10 mg/L; gasometria (se feita) sem hipercapnia/acidose	Broncodilatador + corticoide 5 dias ± antibiótico; observação no PS ou ambulatorial com retorno precoce
Grave	Dispneia, FR, FC e SpO ₂ como acima + gasometria com PaCO₂ >45 mmHg e pH <7,35 (acidose respiratória aguda ou agudizada)	Hospital; O ₂ controlado; VNI precoce ; UTI se falha/pH <7,25 → transferir

Além dos critérios de Roma, indicam gravidade e internação [GOLD 2026]: sintomas graves (dispneia em repouso, FR >30, uso de musculatura acessória, cianose, confusão, sonolência), insuficiência respiratória aguda (PaO₂ <60 / SpO₂ <90% apesar de O₂), sinais novos (edema, arritmia), comorbidade grave (IC, FA, DRC), falha do tratamento inicial, exacerbações frequentes, falta de suporte domiciliar, O₂/VNI domiciliar.

2.3 Critérios de Anthonisen (para decidir antibiótico)

(1) aumento da dispneia; (2) aumento do volume do escarro; (3) **aumento da purulência do escarro**. Tipo I = 3 critérios; tipo II = 2; tipo III = 1. Antibiótico indicado em: tipo I; tipo II **se um deles for purulência**; e em qualquer exacerbação que necessite de VNI ou IOT [GOLD 2026; Wedzicha 2017]. PCR <20 mg/L sem purulência: antibiótico provavelmente desnecessário (PACE, N Engl J Med 2019).

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Sensório	Sonolência, confusão, flapping = hipercapnia/acidose → gasometria e VNI; agitação = hipoxemia
FR, padrão, musculatura acessória, respiração com lábios semicerrados, fala entrecortada	Esforço e fadiga; respiração paradoxal = exaustão
SpO ₂ em ar ambiente e com o O ₂ habitual	Alvo 88-92%; comparar com o basal do paciente (muitos vivem com 88-90%)
FC, PA, ritmo	FA e taquiarritmias por hipóxia/β2; hipotensão = choque/TEP/pneumotórax hipertensivo
Temperatura	Febre >38,5 °C sugere pneumonia/influenza
Ausculata	Sibilos, roncos, MV difusamente diminuído (enfisema); assimetria (pneumotórax, consolidação, derrame); crepitações bibasais (IC); estridor (outra causa)
Tórax	Hiperinsuflação, tiragem, cianose central
Sinais de IC direita/cor pulmonale	Estase jugular, hepatomegalia, edema de MMII, B2 hiperfonética
Membros inferiores	Sinais de TVP (TEP)
Escarro	Cor/purulência (mostrar ao paciente/familiar a diferença), volume, hemoptise

4. Propedêutica armada [GOLD 2026]

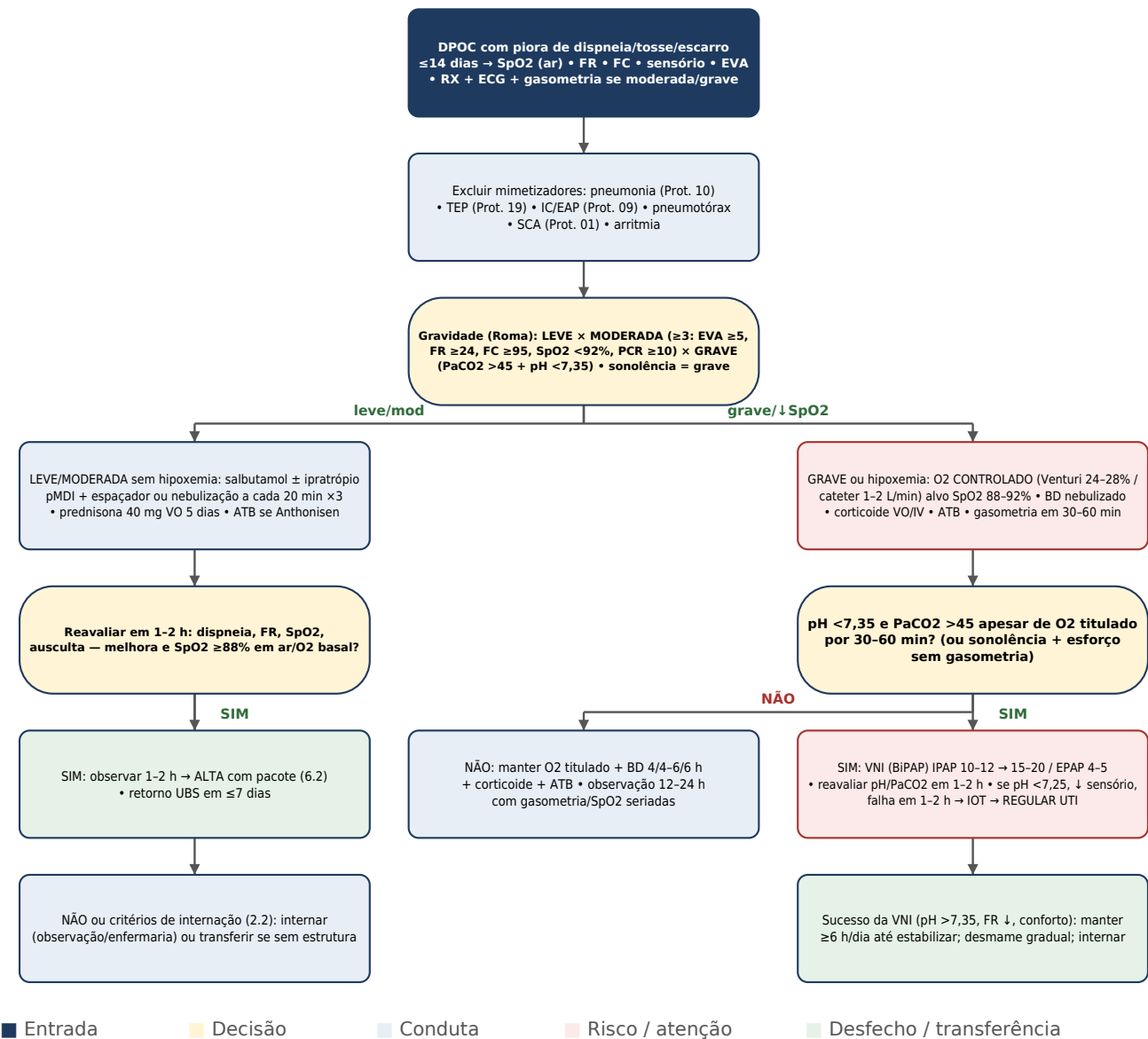
Exame	Para que serve	Quando
Oximetria de pulso	Gravidade e titulação do O ₂	Todos, contínua se moderada/grave
Gasometria arterial	PaCO ₂ >45 + pH <7,35 define exacerbação grave e indica VNI; PaO ₂ <60 = insuficiência respiratória; HCO ₃ alto = retenção crônica	Toda exacerbação moderada/grave, SpO ₂ <92%, sonolência, O ₂ domiciliar, antes e 1 h após VNI [VERIFICAR gasômetro — sem ele, VNI empírica se sonolência + esforço]
Radiografia de tórax	Pneumonia, pneumotórax, derrame, congestão, massa	Toda exacerbação que chega ao PS (diferente da asma)
ECG	FA, isquemia, sobrecarga de VD, sinais de TEP	Todos
Hemograma, PCR, eletrólitos, creatinina, glicemia	Leucocitose/PCR (infecção/pneumonia), policitemia (hipoxemia crônica), hipocalemia (β2 + corticoide), hiperglicemia	Moderada/grave
Troponina, BNP	SCA, IC como causa ou comorbidade	Se dor torácica, edema, suspeita de IC
D-dímero → angio-TC	TEP em exacerbação sem causa aparente ou hipoxemia desproporcional	Selecionado (transferir para angio-TC)
Cultura de escarro / hemocultura	Exacerbador frequente, DPOC grave, ATB recente, VNI/IOT, risco de <i>Pseudomonas</i>	Antes do antibiótico quando factível
Teste rápido influenza/COVID/VSR	Muda antiviral e isolamento	Sazonal
Eosinófilos	<100/μL: menor resposta ao corticoide (evidência emergente); orienta CI na alta	Se disponível no hemograma

5. Fisiopatologia

A DPOC combina bronquiolite obstrutiva (inflamação neutrofílica, hipersecreção, remodelamento) e enfisema (perda de recolhimento elástico e de superfície de troca), com limitação ao fluxo expiratório fixa e hiperinsuflação. Na exacerbação, a infecção ou o irritante amplifica a inflamação, aumenta o muco e o broncoespasmo, agravando o aprisionamento aéreo: o volume pulmonar de repouso sobe, o diafragma achata e perde eficiência, o trabalho respiratório dispara e a ventilação alveolar cai — surge a **hipercapnia**. O oxigênio em alto fluxo piora a hipercapnia por três mecanismos: libera a vasoconstrição hipóxica em áreas mal ventiladas (piora V/Q), desloca CO₂ da hemoglobina (efeito Haldane) e, em menor grau, reduz o drive ventilatório — daí o alvo de **88-92%** (Austin 2010: O₂ titulado reduziu a mortalidade pela metade em relação ao alto fluxo). A acidose respiratória aguda (pH <7,35 com PaCO₂ alta) sinaliza fadiga muscular; a **VNI** descarrega a musculatura, aumenta o volume corrente e contrapõe o auto-PEEP, reduzindo IOT e mortalidade em ~50% (ERS/ATS 2017). O corticoide sistêmico encurta a recuperação e reduz recaídas com 5 dias (REDUCE), sobretudo em eosinofílicos; o antibiótico beneficia quem tem purulência (carga bacteriana) ou precisa de ventilação. Hipercapnia crônica compensada (HCO₃ alto, pH normal) não é indicação de VNI por si.

6. Fluxo de atendimento [GOLD 2026, cap. 5, adaptado]

O₂ titulado, broncodilatador e corticoide começam na triagem; a gasometria em 30–60 min decide a VNI. **Sonolência num DPOC hipoxêmico é hipercapnia até prova em contrário — não sedar.**



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Triagem → O ₂ titulado (se SpO ₂ <88%) e 1ª dose de broncodilatador	≤10 min
Chegada → gasometria (moderada/grave)	≤30-60 min; repetir 1 h após mudança de O ₂ /VNI
Chegada → corticoide sistêmico	≤1-2 h (moderada/grave)
Acidose respiratória → início da VNI	≤60 min (cada hora de atraso aumenta IOT)
Falha da VNI (pH/sensório/FR sem melhora)	Decidir IOT/transferência em 1-2 h — não prolongar tentativa
Decisão alta × internação	≤4-6 h

6.2 Critérios de alta e pacote de alta [GOLD 2026; PCDT-MS]

Critérios (todos)	Pacote obrigatório
- Broncodilatador de curta ação necessário com intervalo ≥ 4 h - Deambula no quarto, come e dorme sem dispneia limitante - Clinicamente estável por 12-24 h; $\text{SpO}_2 \geq 88-90\%$ em ar ambiente ou no O_2 domiciliar já prescrito; gasometria estável (se grave) - Sem hipercapnia aguda não resolvida - Comorbidades controladas; entende o tratamento; tem suporte em casa; sem indicação de O_2 domiciliar nova sem providência	- Prednisona 40 mg/dia completando 5 dias (sem desmame) - Antibiótico completando 5-7 dias, quando indicado Revisar e otimizar a manutenção: LAMA e/ou LABA (PCDT-MS: tiotrópio, formoterol, salmeterol; LABA+CI se eosinófilos ≥ 300 ou exacerbações frequentes); checar técnica inalatória e espaçador - Cessação do tabagismo (abordagem + encaminhamento ao PNCT/UBS; terapia de reposição de nicotina) - Vacinas: influenza anual, pneumococo, COVID, VSR (≥ 60 anos), dTpa - Avaliar O_2 domiciliar se $\text{SpO}_2 \leq 88\%$ estável em ar ambiente após 2-4 semanas (não prescrever na exacerbação) - Plano de ação escrito; retorno na UBS em ≤ 7 dias; encaminhar a pneumologia/reabilitação pulmonar (após exacerbação reduz reinternação)

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Oxigênio controlado [GOLD 2026; Austin 2010]

Item	Conduta
Alvo	SpO_2 88-92% (PaO_2 55-60 mmHg). Nunca "o máximo possível"
Dispositivo	Máscara de Venturi 24-28% (FiO_2 conhecida) ou cateter nasal 1-2 L/min, titulando 0,5-1 L/min por vez; evitar máscara não reinalante fora da PCR/choque
Monitorização	Gasometria 30-60 min após iniciar/mudar; se PaCO_2 subir >10 mmHg ou pH cair $\rightarrow$ reduzir FiO_2 e considerar VNI; nunca suspender O_2 abruptamente (hipoxemia rebote)
Cateter nasal de alto fluxo	Alternativa em hipoxemia sem acidose ou intolerância à VNI; não substitui VNI na acidose hipercápnica (ERS 2022; GOLD 2026) [VERIFICAR disponibilidade]
Transporte	Orientar SAMU: alvo 88-92%; não "ligar a 15 L"

7.2 Broncodilatadores [GOLD 2026; SBPT]

Fármaco	Dose	Observações
Salbutamol pMDI 100 mcg + espaçador	4-8 jatos a cada 20 min na 1ª hora (até 3x), depois 4-8 jatos a cada 4-6 h	pMDI + espaçador = nebulização; preferir em paciente cooperativo (menos aerossol, mais rápido)
Salbutamol nebulizado 5 mg/mL	2,5-5 mg (10-20 gotas) em 3-4 mL SF; a cada 20 min x3, depois 4/4-6/6 h	Nebulizar com ar comprimido ou $\text{O}_2 \leq 6$ L/min por ≤ 10 min (hipercapnia com O_2 a 8-10 L/min por 15 min)
Ipratrópio 0,25 mg/mL	0,25-0,5 mg (20-40 gotas) junto com o salbutamol, a cada 20 min x3, depois 6/6 h	Associação reduz internação; suspender tiotrópio enquanto usa ipratrópio em dose alta (ou manter — GOLD aceita manter os de longa ação)
Fenoterol	5-10 gotas (2,5-5 mg) se salbutamol indisponível	Mais taquicardia/hipocalemia
Broncodilatadores de longa ação (LABA/LAMA)	Manter ou iniciar assim que possível durante a internação (GOLD 2026)	Não interromper na exacerbação
Aminofilina/teofilina IV	—	Não recomendada (efeitos adversos sem benefício — GOLD 2026)

7.3 Corticosteroide sistêmico [GOLD 2026; REDUCE]

Via	Dose	Observações
Oral (preferir)	Prednisona 40 mg/dia por 5 dias , sem desmame	Tão eficaz quanto IV; reduz falha, recaída e tempo de internação; eosinófilos <100/μL predizem menor benefício (não é critério para omitir na grave)
Intravenosa	Metilprednisolona 40 mg/dia (ou hidrocortisona 100 mg 8/8 h) enquanto não deglute	Converter para VO assim que possível; cursos >5-7 dias aumentam pneumonia/hiperglicemia sem benefício
Budesonida nebulizada	2 mg 6/6 h	Alternativa ao sistêmico em casos selecionados (GOLD); custo/disponibilidade [VERIFICAR]

7.4 Antibióticos [GOLD 2026; Wedzicha 2017] — 5 dias (até 7 se pneumonia excluída mas grave) [VERIFICAR com CCIH]

Cenário	Esquema (adulto, função renal normal)	Observações
Indicação: Anthonisen I; II com purulência; VNI/IOT	—	Sem purulência e PCR <20: geralmente sem ATB (PACE)
Sem fator de risco (VEF ₁ >50%, <2 exacerbações/ano, sem cardiopatia grave, sem ATB recente)	Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg 12/12 h (ou 500/125 8/8 h) por 5 dias; alternativas: azitromicina 500 mg/dia 3 dias (ou 500 → 250 mg/dia 5 dias), claritromicina 500 mg 12/12 h, doxiciclina 100 mg 12/12 h	Resistência local do pneumococo a macrolídeo [VERIFICAR]
Com fator de risco (VEF ₁ <50%, ≥2 exacerbações/ano, cardiopatia, ATB ≤3 meses, internação recente)	Amoxicilina-clavulanato; se falha/alergia: levofloxacino 750 mg/dia ou moxifloxacino 400 mg/dia por 5 dias	Quinolona: QT, tendinite, cautela em idoso; reservar
Risco de <i>Pseudomonas</i> (colonização/isolamento prévio, bronquiectasias, VEF ₁ <30%, corticoide crônico, ATB frequente, VM)	Colher escarro; ciprofloxacino 750 mg 12/12 h VO ou, se grave, piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h / cefepima 2 g 8/8 h IV	Ajustar por cultura; transferir se IV prolongado
Pneumonia associada	Protocolo 10 (ceftriaxona + macrolídeo etc.)	—
Influenza suspeita/confirmada	Oseltamivir 75 mg 12/12 h por 5 dias, iniciar em ≤48 h (em DPOC, iniciar mesmo após 48 h se grave)	Notificar SRAG se internado

7.5 Ventilação não invasiva [ERS/ATS 2017; GOLD 2026]

Item	Conduta
Indicações (qualquer)	Acidose respiratória (pH ≤7,35 e PaCO ₂ ≥45) apesar de O ₂ titulado; dispneia grave com sinais de fadiga/aumento do trabalho respiratório (uso de acessórios, paradoxal, tiragem); hipoxemia persistente apesar de O ₂ . Sem gasometria: sonolência + esforço = iniciar VNI e transferir
Contraindicações	Parada respiratória/instabilidade grave; rebaixamento que impede proteção de via aérea (Glasgow <10 sem melhora rápida); vômitos/secreção incontrolável; trauma/cirurgia facial; pneumotórax não drenado; recusa. Hipercapnia com sonolência leve não contraindica — tentar 1 h com vigilância
Ajustes iniciais (BiPAP)	Modo S/T; EPAP 4-5 cmH ₂ O (contrapõe auto-PEEP); IPAP 10-12 , aumentar 2 cmH ₂ O a cada 5-10 min até 15-20 conforme conforto e VC 6-8 mL/kg; FR de backup 12-15; O ₂ para SpO ₂ 88-92%; máscara oronasal; rampa; cabeceira >30°
Monitorização	FR, SpO ₂ , sensorio, conforto, sincronia, vazamento, distensão gástrica a cada 15-30 min na 1ª hora; gasometria em 1-2 h : sucesso = pH ↑ e PaCO ₂ ↓, FR ↓; falha = pH <7,25 ou sem melhora, ↓ sensorio, agitação, intolerância → IOT
Duração	Contínua nas primeiras horas; depois ≥6 h/dia com pausas para alimentação/nebulização; desmame quando pH >7,35 e FR <24 em ar/O ₂ baixo por ≥24 h
IOT	Falha da VNI, PCR, choque, coma; sequência rápida com cautela (hipotensão por auto-PEEP e sedação); ventilação: VC 6-8 mL/kg, FR 10-14, I:E ≥1:3, PEEP ~80% do auto-PEEP, hipercapnia permissiva; transferir para UTI

7.6 Medidas adjuvantes

- **Profilaxia de TEV** em todo internado: enoxaparina 40 mg SC 1×/dia (GOLD 2026).
- Balanço hídrico; diurético só se congestão; nutrição; corrigir K/Mg; glicemia (corticoide); evitar sedativos e opioides fora da IOT/paliação.
- Fisioterapia respiratória para higiene brônquica em hipersecretores; deambulação precoce.
- Comorbidades: betabloqueador cardiosseletivo **não** deve ser suspenso em cardiopata; tratar FA, IC, DM.
- Cuidado paliativo: DPOC muito grave com exacerbações repetidas, VEF₁ <30%, O₂ domiciliar, caquexia — discutir metas (IOT?) antes da próxima crise; opioide em dose baixa para dispneia refratária (morfina 2,5–5 mg VO 4/4 h) é apropriado no paliativo, não na exacerbação tratável.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Falha da VNI, pH <7,25, IOT, rebaixamento, instabilidade hemodinâmica	Imediata	UTI
Exacerbação grave (acidose) com VNI em curso, sem leito monitorado 24 h no PS	Imediata / mesmo dia	UTI ou enfermaria com VNI
Moderada com hipoxemia persistente, comorbidade descompensada, pneumonia, TEP, sem suporte domiciliar	Mesmo dia	Enfermaria de referência (ou observação 24 h no PS se houver O ₂ /monitor/gasometria)
Leve/moderada com boa resposta em 1–2 h	Alta com pacote e retorno ≤7 dias	APS

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 com **O₂ titulado para 88–92%** (Venturi), VNI portátil se disponível, monitor, broncodilatador, material de via aérea; sentado.
- Relatório: gravidade (Roma), gasometrias seriadas (hora, FiO₂), parâmetros de VNI e resposta, doses/horários de broncodilatador/corticoide/ATB, RX/ECG, culturas colhidas, comorbidades, O₂ domiciliar, VEF₁ conhecido, exacerbações prévias, diretivas/metast de cuidado.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência com UTI: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.3 O que o PS precisa ter

- Máscaras de Venturi (24/28/31%), gasômetro (ou fluxo pactuado para gasometria em ≤30 min), BiPAP com máscaras oronasais em tamanhos variados, oxímetro contínuo, espaçadores, nebulizador a ar comprimido.
- Estoque: salbutamol/fenoterol, ipratrópio, prednisona, amoxicilina-clavulanato, azitromicina, doxiciclina, levofloxacino, oseltamivir, enoxaparina.
- Fluxo de contrarreferência para a UBS com dispensação da manutenção (PCDT-MS: LAMA/LABA/CI na farmácia de alto custo — receita e LME) e encaminhamento ao programa de tabagismo.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com SpO ₂ e gravidade (Roma) registradas na chegada	100%
% de O ₂ prescrito com alvo 88–92% documentado; episódios de SpO ₂ >95% em O ₂ (evento)	≥95% / registrar
% de moderadas/graves com gasometria em ≤60 min	≥90%
% de acidose respiratória com VNI iniciada em ≤60 min	≥90%
% com corticoide sistêmico ≤5 dias e ATB por critério documentado (Anthonisen/PCR)	≥90%
% de altas com manutenção revisada, orientação de tabagismo, vacinas e retorno ≤7 dias	≥80%
Uso de aminofilina, sedativo fora de IOT, O ₂ em alto fluxo sem alvo (eventos sentinela)	0
Reinternação por DPOC em 30 dias	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Classificação de gravidade	GOLD 2026 adota Roma (clínica na chegada); a crítica publicada (Miravittles 2026) aponta que hipoxemia grave sem hipercapnia também pode exigir suporte. Adotada Roma com a nota de que hipoxemia refratária = internação
Corticoide	GOLD: 5 dias; SBPT/PCDT: 5–7 dias. Adotado 5 dias (REDUCE)
Antibiótico	GOLD: purulência/VNI; ERS/ATS: idem; PCR <20 pode dispensar (PACE). Esquemas: prática consagrada — validar com CCIH e resistência local [VERIFICAR]
Duração do antibiótico	GOLD 2026: ≤5 dias ambulatorial; alguns protocolos 5–7. Adotado 5 (7 se grave)
VNI sem gasometria	Diretrizes exigem gasometria; no PS sem gasômetro, adotada VNI empírica em sonolência + esforço com transferência — declarar como limitação estrutural [VERIFICAR gasômetro]
Alto fluxo nasal	ERS 2022/GOLD 2026: alternativa em hipoxemia; VNI preferida na acidose. Adotado assim
Eosinófilos para decidir corticoide	Evidência emergente (GOLD 2026 menciona); não usada para omitir corticoide em moderada/grave
Manutenção na alta	GOLD 2026 (LABA+LAMA; +CI se eos ≥300) × PCDT-MS 2021 (elenco: tiotrópio, formoterol, salmeterol, budesonida, beclometasona). Adotado o elenco do PCDT com lógica GOLD

10. Referências

- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Prevention, Diagnosis and Management of COPD: 2026 Report (nov/2025), chapter 5. goldcopd.org. Key Changes GOLD 2026 (10/11/2025).
- Celli BR, Fabbri LM, Aaron SD, et al. An updated definition and severity classification of COPD exacerbations: the Rome proposal. *Am J Respir Crit Care Med* 2021;204(11):1251-1258.
- Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Recomendações para o manejo da DPOC / II Consenso Brasileiro de DPOC. *J Bras Pneumol* (edição vigente). Brasil. Ministério da Saúde. PCDT da DPOC. Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 19, de 21/10/2021.
- Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. *Eur Respir J* 2017;50(2):1602426. Oczkowski S, et al. ERS clinical practice guidelines: high-flow nasal cannula in acute respiratory failure. *Eur Respir J* 2022;59(4):2101574.
- Wedzicha JA, Miravittles M, Hurst JR, et al. Management of COPD exacerbations: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. *Eur Respir J* 2017;49(3):1600791.
- Austin MA, Wills KE, Blizzard L, Walters EH, Wood-Baker R. Effect of high flow oxygen on mortality in COPD patients in prehospital setting: randomised controlled trial. *BMJ* 2010;341:c5462. Leuppi JD, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of COPD (REDUCE). *JAMA* 2013;309:2223-2231. Butler CC, et al. C-reactive protein testing to guide antibiotic prescribing for COPD exacerbations (PACE). *N Engl J Med* 2019;381:111-120. Anthonisen NR, et al. *Ann Intern Med* 1987;106:196-204.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de DPOC exacerbada (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração